

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	血小板低下的照護 Nursing care of thrombocytopenia				
編號	A31000-Q03-W-K17	制定者	N17 陳瑩婕	公布日期	99 年 01 月 20 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 12 月 17 日
版本/總頁數	第 3.9 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 10 月 02 日

一、目的

讓護理人員了解化學治療/放射線治療後引起之免疫不全之血小板低下的照護。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

因使用抗癌藥物或放射線治療影響骨髓造血能力、疾病本身直接或間接侵犯到骨髓、感染症、癌症末期擴散，導致小血管病變，造成血小板減少。血小板於人體的正常值為 15~40 萬/mm³，當循環血液中血小板數量小於 10 萬/mm³ 時，臨床上定義為血小板低下(Thrombocytopenia)，若血小板小於 5 萬/mm³，則會有潛在危險性出血傾向，若小於 2 萬/mm³，即會有自發性出血的危險，若小於 1 萬/mm³，病人將會有致命的危險性。依據美國國家癌症研究所(National Cancer Institute, NCI)的血小板低下之危險分級，可分為 1-5 級，如下表：

危險分級	血小板計數(Platelet)
第1級	LLN-75000/mm ³
第2級	50000-75000/mm ³
第3級	10000-50000/mm ³
第4級	<10000/mm ³
第5級	死亡

註：LLN:lower limit of normal（正常下限）

主題名稱	血小板低下的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K17	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	2/8

(二) 症狀

血液中血小板數目不足造成出血傾向，臨床上的各種症狀：

1. 外觀：皮膚黏膜有出血點，紫斑或瘀斑，傷口出血，使用壓脈帶或止血帶處會出現瘀斑，身上存留針頭處可能會有出血現象。
2. 中樞神經系統：顱內壓升高、頭痛、意識混亂或改變、定向感喪失。
3. 呼吸系統：咳血、呼吸型態改變。
4. 消化系統：腸胃道出血、吐血、便血。
5. 泌尿系統：血尿、尿道出血。
6. 生殖系統：月經過多、點狀出血、血狀分泌物。
7. 頭頸部：牙齦出血、流鼻血、血痰、鼻胃管引流液中有血、鞏膜或視網膜出血、視力模糊。

(三) 診斷

病人出現血小板低下時，需排除其他致病因素，臨床上才會懷疑是由藥物導致的不良反應。

1. prothrombin time 正常值：8~12sec，未延長，則初步排除體內出血或血管內瀰漫性凝血反應(disseminated intravascular coagulation, DIC)。
2. total bilirubin 正常值：0.2~1.2mg/dL 和 MCV 正常值：79~99fl，無溶血性貧血證據，則排除栓塞性微血管病變可能性。
3. 骨髓切片檢查：對照過去病史與血液檢查值，確認與骨髓抑制的相關。

(四) 治療與處置

1. 輸血治療，效果快但短暫，具輸血感染危險性。
2. 檢測 CBC 中的血小板計數，以及評估流血及出血的症狀。出血徵象例如瘀青、瘀斑（皮膚下可見帶紫紅色的微小斑點）、鼻出血、延長的經期或經血過多、咖啡色的嘔吐物、血尿。需監測血小板數值及部分凝血酶原時間(PT)、活化部分凝血酶原時間(APTT)。

主題名稱	血小板低下的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K17	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	3/8

3. 檢驗糞便、尿液、嘔吐物等的潛血反應。

(五) 常見治療

有自發性出血的血小板低下病人，需輸注血小板。當血小板數值降到低於一定的閾值時，也會給予預防性的輸注血小板，以降低出血危險。目前對於接受治療的癌症病人，建議的血小板閾值為 1 萬/mm³ 以上；而對有高燒、白血球過高、血小板快速降低或凝血異常的病人，建議血小板閾值為 2 萬/mm³ 以上。藥物方面，對於停經前之婦女常會給予口服避孕藥，以抑制卵巢功能，避免月經出血量過多。

(六) 護理問題

易受傷害／與血小板減少有關。

(七) 護理措施

1. 解釋易出血與疾病本身及血小板減少有關，教導個案耐心接受治療，並注意減少出血危險性的事項：
 - (1) 避免使用阿斯匹靈的製劑。
 - (2) 避免挖鼻孔和擤鼻涕。
 - (3) 使用軟毛牙刷，避免傷害牙齦。
 - (4) 避免任何引起創傷的情況，例如劇烈活動、與粗糙面的摩擦。
 - (5) 避免不必要的侵入性檢查及治療，若穿刺性檢查或治療後，如抽血、骨髓穿刺、動脈或靜脈導管移除等，應延長加壓止血時間至少 5 分鐘以上，至完全止血為止。
2. 監測生命徵象、意識狀態之變化及出血表徵。
3. 監測血液檢驗值。
4. 評估病人的精神狀況、活動時之耐力，避免發生跌倒、碰撞。
5. 加強預防跌倒衛教：
 - (1) 當病人臥床時，隨時圍上床欄。
 - (2) 病床輪子固定。

主題名稱	血小板低下的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K17	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	4/8

(3)穿止滑的拖鞋，並鼓勵至少一位家屬隨時陪伴病人。

(4)告知家屬及病人如何使用呼叫鈴。

6. 指導有關出血的預防和症狀評估。

7. 告知病人及家屬對於早期出血的處理方法：

(1)平躺休息，不要亂動。

(2)壓迫出血處。

(3)儘快通知醫護人員處理。

(八) 衛教指導

1. 未經醫師同意不要任意服用藥物，包括未經處方開立的阿斯匹靈或其他止痛藥，這些藥物都有可能影響到血小板的功能。

2. 未經醫生同意不要飲用任何含酒精性飲料。

3. 如有需要看牙醫，須先告知牙醫血小板偏低的情況。

4. 請用軟毛牙刷來清潔牙齒，避免使用牙線。

5. 擤鼻涕時勿用力，亦不要用手指頭去挖鼻孔。

6. 使用剪刀、針、菜刀、刮鬍刀或其他工具時要小心，注意不要傷到自己，最好使用電動刮鬍刀來刮鬍子。

7. 避免進行碰撞性的身體運動或其他可能造成受傷活動，例如：按摩，刮沙等。

8. 應多喝水並多食用蔬菜水果，以避免大便過硬，而造成解便時肛門出血，同時也不可自行灌腸。

(九) 居家照護

1. 出血症狀的自我觀察，需回院治療時機：皮膚皮下出血，黏膜或器官出血，如血尿、血便、牙齦出血、單側肢體異常腫脹、呼吸困難。

2. 活動：避免碰撞性的身體運動或其他可能造成受傷之活動，如刮痧、按摩。居家使用剪刀、針線、菜刀或其他工具時需小心不可傷到自己，手伸進微波爐或烤箱可戴手套，煮飯、燙衣服需小心不可燙傷。

主題名稱	血小板低下的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K17	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	5/8

3. 飲食：補充水分建議量為 3000c.c.，鼓勵攝取高纖食物，如蔬菜、水果，以防大便過硬造成解便時出血，當病人出現自發性出血時，避免閉氣用力之動作 (Valsalva ,s maneuver)。
4. 遵照醫師指示服用藥物，不可自行服用其他藥物，在用藥上亦有其禁忌，阿斯匹靈類藥物、非類固醇抗炎性藥物、抗凝血劑、penicillin 類抗生素或 phenothiazine 類等藥物均會引起血小板下降。
5. 維持皮膚完整性：刮鬍子建議使用電動刮鬍刀，使用指甲剪修剪指甲。
6. 口腔黏膜照護：使用軟毛牙刷口腔棉棒清洗牙齒；使用不含酒精性的漱口水漱口，避免黏膜刺激；禁止使用牙線剔牙；看牙醫時需告知牙醫師血小板數值；不要用力擤鼻，避免鼻黏膜損傷。
7. 性生殖系統：當血小板低於 1 萬 2 千/mm³ 時，女性病人可能會因月經來潮而出現經血過多情形，若出現經血量過多時，應盡速就醫，並依醫囑服用口服避孕藥，且需避免性生活。
8. 消化道系統：避免測量肛溫或使用肛門塞劑或灌腸，因會對腸黏膜造成刺激而引起出血傾向。
9. 出血處理：需指導病人和家屬早期出血處理，先平躺→加壓止血→抬高出血肢體→冰敷→送醫。

(十) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

主題名稱	血小板低下的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K17	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	6/8

六、參考資料

- (一) 杜玲、陳秀勤、劉清華、楊婉萍(2019)．癌症病人之護理．於胡月娟總校閱，內外科護理學（上）（六版，215-312 頁）．台北：華杏。
- (二) 陳敏銓、黃采薇、趙子傑、簡淑慧、陳秋慧、陳瑞儀、胡文郁、鄭春秋、周繡玲、許麗珠、楊克平、顧乃平(2017)．癌症護理學（4 版）．台北：華杏。

七、附件

(略)

主題名稱	血小板低下的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K17	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	7/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
99.01.20	1.0	新制定。	99 年 01 月 20 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
101.08.31	2.1	1. 醫護部改護理部。 2. 目的及說明修辭更正錯別字。	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	3.1	說明內容更正錯別字。	103 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
104.08.31	3.2	增修第六項參考資料。	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.3	1. 新增第三項第(三)目診斷部份之內容。 2. 新增參考文獻出處於內文中。 3. 第六項參考資料部份增刪及修訂。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.4	第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過。
108.09.23	3.5	第三項第十日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.18	3.6	第三項第一、五、九目之 7 內容部份修辭。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過； 109 年 08 月 12 日護

主題名稱	血小板低下的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K17	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	8/8

修正日期	版本	修正說明	備註
			理長會議通過;109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.10.19	3.7	第六項參考資料修訂。	110 年 10 月 07 日照護標準組會議通過;110 年 10 月 13 日護理長會議通過;110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.11.08	3.8	1. 第三項第一目、第三目、第六目、第七目之 1 內容部份修辭。 2. 更新第六項參考資料。 3. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過;111 年 10 月 12 日護理長會議通過;111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.10.26	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.17	3.9	刪除第六項參考資料年限較久參考文獻。	113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過;113 年 12 月 11 日護理長會議通過;113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
114.10.02	3.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	